

Question 7 : L'orthopantomographie

- A. Est réalisée en position debout ou assise
- B. Incidence impossible à réaliser en décubitus
- C. La mandibule repose sur un étrier où elle est calée
- D. La contention peut comporter un guide buccal et un serre-tête

Question 8 : Profil d'Arcelin

- A. Est une incidence de profil chirurgical de la hanche
- B. Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en flexion.
- C. La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur cuisse.
- D. La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté à radiographier.

Question 9 : Critères de réussite d'une incidence oblique du rachis cervical

- A. Bon dégagement des trous de conjugaison à tous les niveaux.
- B. Superposition des apophyses articulaires droite et gauche.
- C. Dégagement de toutes les interlignes articulaires.
- D. Bonne visualisation des pédicules du côté examiné.

Question 10 : Les critères de réussite d'une radiographie du bassin de face :

- A. Superposition de l'axe du sacrum et de la symphyse pubienne.
- B. Dégagement externe complet du grand trochanter.
- C. Petit trochanter coupé par la corticale de la diaphyse fémorale
- D. Trous obturateurs symétriques.

Question 11 : Radiographie du rachis cervical « bouche ouverte » :

- A. Incidence de face antéro-postérieure.
- B. Permet la visualisation du processus odontoïde et l'atlas.
- C. Rayon directeur est horizontal.
- D. Réalisée en décubitus en cas de traumatisme important.

Question 12 : Incidence de Lamy :

- A. Incidence de profil de l'épaule.
- B. Réalisée chez un sujet en position debout en oblique antérieure de 45 à 60° du côté examiné.
- C. Le bras est pendant, coude fléchi et légèrement porté en arrière.
- D. Rayon directeur est horizontal.

Question 13 : Radiographie de face de la clavicule :

- A. Rayon directeur est postéro-antérieur.
- B. Rayon directeur est horizontal.
- C. Visualisation de la clavicule dans sa totalité.
- D. Visualisation des articulations acromio-claviculaire et sterno-claviculaire.

✓ Question 28 : **Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr :**

- A. Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie
- B. Le Cliché sans préparation est obligatoire et permet de recherche des calcifications au niveau de l'hypochondre droit.
- C. L'injection du produit de contraste est suivie en scopie.
- D. L'injection du produit de contraste est rapide.

✓ Question 29 : **Un uroscanner :**

- A. Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale.
- B. Est indiqué devant une obstruction urinaire.
- C. Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires.
- D. Est contre-indiquée en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l.

✓ Question 30 : **En cas d'insuffisance rénale aigue :**

- A. L'injection du produit de contraste iodé est contre-indiquée.
- B. Une hypohydratation avant et après l'injection de produit de contraste iodé doit être réalisée.
- C. Les médicaments néphrotoxiques doivent être arrêtés pendant au moins 48 heures.
- D. Un intervalle d'au moins 3 jours entre deux injections de produit de contraste iodé s'impose

✓ Question 31 : **La vaccination au Maroc commence :**

- A. immédiatement après la naissance.
- B. A une semaine de la naissance.
- C. A six semaines de la naissance.
- D. A dix semaines de la naissance.

✓ Question 32 : **Le programme de vaccination au Maroc vise à prévenir les maladies suivantes :**

- A. L'hépatite virale C.
- B. L'hépatite virale B.
- C. La rubéole.
- D. La varicelle.

✓ Question 33 : **La prophylaxie correspond aux :**

- A. Mesures entreprises pour traiter les cas
- B. Mesures entreprises pour éviter la survenue de la maladie.
- C. Mesures entreprises pour éviter la contagion de la maladie.
- D. Actions entreprises pour la prise en charge psychologique de l'entourage du malade.

✓ Question 34 : **L'indice synthétique de fécondité au Maroc en 2013 est de :**

- A. Un enfant par femme.
- B. Deux enfants par femme.
- C. Trois enfants par femme.
- D. Quatre enfants par femme.

23- Radiographie de face de la clavicule :

- A. Rayon directeur est postéro-anterior
- B. Rayon directeur est horizontal
- C. Visualisation de la clavicule dans sa totalité
- D. Visualisation des articulations acromio-claviculaire et sterno-claviculaire.

24- Radiographie du coude de face :

- A. Patient assis, membre supérieur en extension sur la table et main en supination
- B. Rayon directeur est vertical
- C. Centrage au milieu du pt du coude
- D. Centrage au bord postérieur de l'épicondyle.

25- Incidence de Schreck II :

- A. Realisée sur main fléchie en position d'écriture et en demi-supination à 25°
- B. Rayon incident est vertical
- C. Centrage à 1cm en avant de l'interligne radio-carpienne.
- D. Incidence permettant l'analyse du scaphoïde.

26- Incidence de profil chirurgical de la hanche :

- A. Profil il-Arcolat
- B. Patient en decubitus, membre inférieur à radiographier en extension
- C. La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur la cuisse
- D. La cuisse est appliquée contre l'abdomen de côté opposé.

27- La prémédication avant un examen avec injection de produit de contraste iodé :

- A. Doit être utilisé pour rassurer le patient
- B. N'empêche pas le survenir d'une anaphylaxie
- C. Est remplacée actuellement par la consultation d'allergologue
- D. Est systématique pour les patients aux antécédents d'anaphylaxie pour un certain produit de contraste

28- Urographie intra-veineuse :

- A. Contre-indiqué chez la femme enceinte
- B. Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices
- C. Est actuellement remplacée par l'uroscanner
- D. Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral passif et actif

29- La Fibrose Néphrogénique Systémique

- A. Atteinte cutanée puis systémique des articulations, du cœur et des poumons
- B. Peut être responsable du décès du patient
- C. Secondaire à l'injection de chélate de gadolinium lors d'examen IRM
- D. Survient chez des patients insuffisants rénaux avec une clairance de la créatinine > 30ml/min

20-En mammographie, le rayonnement diffusé :

- A- Entraîne un noircissement du film sans apporter plus d'informations.
- B- Diminue la fiabilité diagnostique.
- C- L'utilisation de clichés centrés simples augmente ce rayonnement.
- D- Est plus important dans les seins très denses.

21-En mammographie, la compression du sein :

- A- Est indispensable pour diminuer le contraste.
- B- Est relativement facile en cas de tissu mammaire sain.
- C- Augmente de façon sensible la dose d'irradiation.
- D- Réduit de façon sensible le rayonnement diffusé.

22-Les critères de qualité d'un cliché oblique externe en mammographie :

- A- Muscle pectoral doit être visible jusqu'à hauteur du mamelon.
- B- Le muscle pectoral doit faire avec le bord latéral du film un angle d'environ 45°.
- C- Le sillon sous-mammaire doit être visible sur le cliché.
- D- Le tissu glandulaire doit être bien étalé.

23-L'Hystérosalpingographie :

- A- Est indiquée en cas d'infection génitale.
- B- Est indiquée en cas d'infertilité secondaire.
- C- Une couverture antibiotique est systématique.
- D- Est réalisée en deuxième partie de cycle permet afin d'éviter une dissection de l'endomètre lors de l'introduction du cathéter.

24-En IRM, la pondération T2 se caractérise par :

- A- Un temps d'écho est > 80 ms
- B- Un temps de répétition > 2000 ms
- C- Un temps d'écho est > 20 ms
- D- Un hypersignal des structures liquidiennes.

25-En IRM, les antennes en réseau phasé :

- A- Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées côte à côte.
- B- Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées face à face.
- C- Permettent un très bas signal sur bruit.
- D- Permettent un petit champ d'exploration

31. Les services déconcentrés du Ministère de la Santé sont représentés par :

- A. Les directions régionales de santé
- B. Les directions centrales
- C. les CHU
- D. Les délégations provinciales de santé

32. Laquelle des directions suivantes ne fait pas partie du ministère de la Santé :

- A. Direction de la population
- B. Direction des médicaments et de pharmacie
- C. Direction de santé publique
- D. Direction de réglementation et de contentieux

33. Une Direction Régionale de santé est composée de :

- A. 5 unités régionales
- B. 6 unités régionales
- C. 7 unités régionales
- D. 3 à 4 services

34. Le réseau de soins de santé de base comporte :

- A. Centre de santé communal
- B. Centre de santé urbain
- C. Hôpital local
- D. Dispensaires rural

35. Lequel des établissements suivant ne sont pas généralement médicalisés :

- A. Dispensaire rural
- B. Centre de santé communal
- C. Centre de santé urbain
- D. Centre de santé communal avec unité d'accouchement

36. Un hôpital régi en mode d'établissement public autonome est un hôpital :

- A. Qui a une autonomie administrative et n'a pas d'autonomie financière
- B. Qui a une autonomie financière et n'a pas d'autonomie administrative
- C. Qui n'a ni autonomie administrative ni autonomie financière
- D. Qui a une autonomie administrative et une autonomie financière

- 7- Incidence des os propres du nez :
- A. Incidence antéro-postérieure.
 - B. Centrage à la base du nez.
 - C. L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -30° .
 - D. L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -70° .
- 8- Incidence Blondeau :
- A. Est une incidence qui permet d'analyser les sinus de la face.
 - B. L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -50° .
 - C. Nez est à 1cm de la plaque.
 - D. Equidistance des conduits auditifs externes par rapport à la cassette.
- 9- Radiographie $\frac{1}{4}$ (obliques) du rachis cervical :
- A. Patient en position debout ou assis en oblique postérieure du côté examiné.
 - B. L'angle d'obliquité est de 45° à 60° .
 - C. Rayon directeur est ascendant de 20° .
 - D. Centrage sur la face latérale du cou, à hauteur de C2.
- 10- Radiographie des sacro-iliaques :
- A. Réalisée en décubitus avec membres inférieurs légèrement fléchis.
 - B. Rayon directeur incliné vers la tête de 15° à 20° .
 - C. Centrage à deux travers de doigt au-dessous du bord supérieur du pubis, sur la ligne médiane.
 - D. Incidence antéro-postérieure.
- 11- Incidence de Chevrot :
- A. Incidence oblique, visualisant l'articulation sacro-iliaque dans le plan horizontal.
 - B. Patient en décubitus, tronc fléchi en appui sur les coudes et membres inférieurs en extension.
 - C. Bassin soulevé de 20° du côté à radiographier grâce à une cale en mousse.
 - D. Rayon directeur est incliné de 30° à 50° vers les pieds.
- 12- Incidence de Lamy :
- A. Incidence permettant l'exploration de la ceinture scapulaire.
 - B. Patient debout en oblique antérieure de 45° à 60° du côté opposé.
 - C. Le bras est pendait, coude fléchi et légèrement porté en arrière.
 - D. Rayon directeur est horizontal.

13-Les critères de réussite d'une incidence de Neer :

- A. L'omoplate se présente sous la forme d'un « Y ».
- B. L'écaillé est vue de face.
- C. L'articulation gléno-humérale bien dégagée.
- D. Articulation acromio-claviculaire est visible.

14-Radiographie du coude de profil :

- A. Patient assis, coude fléchi à 45° reposant sur la plaque par son bord interne, main verticale.
- B. Rayon directeur est vertical.
- C. Centrage au bord postérieur de l'épicondyle.
- D. Centrage au bord postérieur de la trochlée.

15-Incidence de Schreck II :

- A. Réalisée sur main fléchie en position d'écriture et en demi-supination à 25°.
- B. Rayon incident est vertical.
- C. Centrage à 1cm en avant de l'interligne radio-carpienne.
- D. Incidence permettant l'analyse du scaphoïde.

16-Incidence de profil chirurgical de la hanche :

- A. Profil d'Arcein.
- B. Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en extension.
- C. La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur la cuisse.
- D. La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté opposé.

17-Urographie intra-veineuse :

- A. Peut être indiquée devant un syndrome obstructif urinaire.
- B. Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices.
- C. Est actuellement supplantée par l'uroscanner.
- D. Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif.

18-Urétrocystographie rétrograde :

- A. L'injection du produit de contraste est réalisée par voie intra-veineuse.
- B. Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral actif lors du remplissage.
- C. Un cliché post-mictionnel est indispensable.
- D. Est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale.

19-L'incidence qui permet d'étudier l'apophyse zygomatique est :

- A. Incidence de HIRTZ SUBAXIALE.
- B. Worms-Bretton (incidence semi-axiale).
- C. Incidence de crâne de face.
- D. Incidence de crâne de profil.

- 1- Incidence de crâne de face haute est :
 - A. Une incidence antéro-postérieure.
 - B. Réalisée chez un sujet assis avec un appui front-nez.
 - C. Réalisée chez un sujet assis avec un appui sur le front.
 - D. Centrage est basé sur l'équidistance des deux conduits auditifs externes par rapport au plan de projection.
- 2- Les critères de réussite d'une incidence de crâne de face haute sont :
 - A. Fentes sphénoïdales dans les orbites.
 - B. Bords supérieurs des rochers confondus avec les rebords orbitaires inférieurs.
 - C. Distance apophyse orbitaire du malaire et table interne de la voûte latérale est identique des deux côtés.
 - D. Distance apophyse orbitaire du malaire et table externe de la voûte latérale est identique des deux côtés.
- 3- Incidence de crâne de profil :
 - A. L'angle formé entre le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de 15° .
 - B. Rayon directeur est horizontal.
 - C. Le centrage est à 3cm au-dessus du tragus.
 - D. Le centrage est à 3cm au-dessous du tragus.
- 4- Les critères de réussite d'une incidence de crâne de profil :
 - A. Superposition droite-gauche des planchers orbitaires.
 - B. Superposition des grandes ailes du sphénoïde.
 - C. Superposition des conduits auditifs externes.
 - D. Superposition des apophyses clinoides.
- 5- Incidence de HIRTZ :
 - A. Le centrage est au niveau de la ligne bi-oculaire.
 - B. Indiquée en cas de traumatisme du rachis cervical.
 - C. L'angle formé par le rayon directeur et le plan sagittal médian est de 0° .
 - D. L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de -150° .
- 6- Incidence de Worms-Bretton (incidence semi-axiale) :
 - A. Le plan orbito-méatal oblique au plan de projection.
 - B. Equidistance des deux conduits auditifs externes à la cassette.
 - C. Les rochers sont situés largement au-dessus des rebords orbitaires supérieurs.
 - D. L'angle formé par le rayon directeur et le plan orbito-méatal est de 25° .